

# 中山醫學大學附設醫院

|        |                                     |     |        |      |                 |
|--------|-------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 主題名稱   | 小兒腹股溝疝氣<br>Children Inguinal hernia |     |        |      |                 |
| 編號     | A31000-Q03-W-N15                    | 制定者 | IR 黃淑媛 | 公布日期 | 100 年 08 月 31 日 |
| 制定單位   | 護理部                                 | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 112 年 11 月 21 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.6 版/6 頁                         | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 10 月 02 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解小兒腹股溝疝氣的定義、症狀、常見檢查及診斷、治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部新生兒、小兒科單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）定義

小兒疝氣即小兒腹股溝疝氣，俗稱「脫腸」，是小兒泌尿科手術中最常見的疾病。在胚胎時期，腹股溝處有一「腹股鞘狀突」，可以幫助睪丸降入陰囊或子宮圓韌帶的固定。有些小孩出生後，此鞘狀突關閉不完全，導致腹腔內的小腸、網膜、卵巢、輸卵管等進入此鞘狀突，即成為疝氣；若僅有腹腔液進入陰囊內，即為陰囊水腫。疝氣一般發生率為 1-4%，男生是女生的 9-10 倍，早產兒則更高，且可能發生於兩側。

### （二）症狀

常見和最典型的疝氣是在腹股處發現有隆起腫塊，有些甚至會腫至陰囊部位。多數是在哭鬧、咳嗽、打噴涕、久站或劇烈運動後才突起來，但經平躺或休息後便會自然消失，有時須用手將它壓回去。單純的疝氣所引起的疼痛，通常不會很厲害，但如果腹股溝處發生持續的劇痛，同時腫塊無法壓回去，且症狀持續二、三天，就有可能是因掉入的腸子、輸卵管等壞死，這是非常嚴重的併發症，可能有生命的危險。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 小兒腹股溝疝氣          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N15 | 版本   | 第 2.6 版 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

### （三）常見檢查及診斷

1. 要診斷疝氣的最好辦法就是看到其膨出於腹股溝或掉到陰囊內，設法使小孩子腹部用力就可看到凸起，稍加壓力就可感覺有東西掉回腹腔內，若母親可清楚的描述這種現象，也可診斷為腹股溝疝氣。
2. 至於在沒有膨出的狀態下，要以理學檢查來確定診斷有時會有困難，常掉下來的疝氣睪丸上方的精索看起來會比較肥厚而充實，有時摸到疝氣袋壁兩層互相磨擦的感覺(silk sign)，用指尖由陰囊往外環觸探可感覺較正常略大的腹壁缺損，但這都不是很可靠的。
3. 疝氣造影(Herniography)及診斷性腹腔鏡雖可確定診斷但副作用不少，很少有人贊成採用。
4. 有時小孩提睪肌力量太大，往往把正常位置的睪丸往上拉到腹股溝，形成與疝氣類似的膨出但可拉回來陰囊內，所以疝氣的診斷應先確定睪丸的位置，同時隱睪症因常合併疝氣（約 80%），兩者的診斷與治療最好同時考慮。

### （四）治療

1. 手術是小兒疝氣最好的治療方法，一般皆以全身麻醉，採高位結紮的方法，手術安全且時間不長。若有疝氣發生，宜早日治療，以免疝氣囊之內容物發生箝閉，增加手術的困難與生命的危險。
2. 腹股溝疝氣手術後，主要是傷口護理，需告知要經常換尿布，保持清潔。

### （五）護理問題

1. 易受傷害／組織嵌頓壞死。
2. 易感染／術後傷口。

### （六）護理措施

1. 易受傷害／組織嵌頓壞死。
  - (1) 原則上病人可以正常的活動，但要避免腹部過度用力之動作，如厲害的咳嗽、哭鬧、用力解便、劇烈之運動等。
  - (2) 術後傷口絕對不可以沾水，所以暫勿洗澡，可用擦澡方式清潔身體，大約五、

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 小兒腹股溝疝氣          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N15 | 版本   | 第 2.6 版 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

六天後視傷口癒合情形，再恢復正常洗澡。

(3)傷口最表層通常只會使用美容膠布、紗布或透明膜覆蓋，內層則以羊腸線縫合，因為羊腸線能自行吸收，所以不必拆線。

(4)請隨時保持傷口清潔、乾燥，並依醫師的叮嚀按時換藥，同時切記覆蓋傷口之美容膠布千萬不要自行撕掉。

(5)如果傷口出現出血、紅、腫、傷口裂開、有滲出液、發高燒等情形時，請立即回醫院診治。

## 2. 易感染／術後傷口。

(1)手術後四小時內需禁食包括開水。

(2)四小時後，若腸胃蠕動正常，可先喝開水，若無嘔吐或其他不適，則可進食軟質及易消化食物。

(3)為預防便秘及預防手術後可能的輕微發燒情況，請多喝開水。

(4)原則上病人可以正常的活動，但要避免腹部過度用力之動作，如厲害的咳嗽、哭鬧、用力解便、劇烈之運動等。

(5)術後傷口絕對不可以沾水，所以暫勿洗澡，可用擦澡方式清潔身體，大約五、六天後視傷口癒合情形，再恢復正常洗澡。

(6)傷口最表層通常只會使用美容膠布、紗布或透明膜覆蓋，內層則以羊腸線縫合，因為羊腸線能自行吸收，所以不必拆線。

(7)請隨時保持傷口清潔、乾燥，並依醫師的叮嚀按時換藥，同時切記覆蓋傷口之美容膠布千萬不要自行撕掉。

(8)如果傷口出現出血、紅、腫、傷口裂開、有滲出液、發高燒等情形時，請立即回醫院診治。

## (七) 衛教指導

參考衛教單張：

1. T-Ped-008\_小兒疝氣。

2. E-Ped-017\_小兒疝氣手術前後須知。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 小兒腹股溝疝氣          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N15 | 版本   | 第 2.6 版 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

#### (八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(略)

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

- (一) 莊安慧(2019)・消化系統疾病患童的護理・於穆佩芬總校閱・*兒科護理學* (461-463 頁)，新文京開發。
- (二) 黃立琪(2021)・兒童消化系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱・*實用兒科護理學* (九版，523-562 頁)，華杏。

### 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 小兒腹股溝疝氣          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N15 | 版本   | 第 2.6 版 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                 | 備註                                                                           |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 100.08.31 | 1.0 | 新制定。                                                                 | 100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 102.02.08 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                          |                                                                              |
| 103.06.30 | 2.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                              |
| 104.08.31 | 2.1 | 增修第六項參考文獻資料。                                                         | 104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 105.08.31 | 2.2 | 將參考文獻出處呈現於內文中。                                                       | 105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 106.04.10 | 2.3 | 更新第六項參考文獻。                                                           | 106 年 04 月 10 日護理部照護標準委員會通過。                                                 |
| 107.06.29 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                              |
| 108.09.23 | 2.4 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 | 108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。                              |
| 109.08.06 | 2.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                              |
| 110.10.07 | 2.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                              |
| 111.11.08 | 2.5 | 1. 修正第三項第五、六目護理問題。<br>2. 增修第六項參考文獻資料。<br>3. 內文參考文獻引用刪除。              | 111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；<br>111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。 |

